

Schematy w AvPD

Cztery główne schematy YSQ: **defektywność/wstyd** (centralny), izolacja, zahamowanie emocjonalne, porażka. Tryby: *Vulnerable Child* + *Avoidant Protector*. Bamelis 2014: $d = 0,7-1,0$.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Young i wsp. (2003); Bamelis (2014); Lobbestael (2010)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz cztery główne schematy AvPD (sekcja 01). **2** · Zrozumiesz **tryby Schema Therapy** aktywne w AvPD (sekcja 02). **3** · Sprawdzisz swoje dominujące schematy (sekcja 03). **4** · Zobaczysz, jak terapia schematów **dociera** tam, gdzie CBT się odbija (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Young i wsp. (2003) zidentyfikowali w AvPD **cztery dominujące schematy maladaptacyjne**: *defektywność/wstyd* (centralny), *izolacja społeczna*, *zahamowanie emocjonalne*, *porażka*. Bamelis i wsp. (2014, RCT): terapia schematów osiąga w AvPD efekty $d = 0,7-1,0$ — wyższe niż klasyczna CBT na samym lęku. **Bez identyfikacji schematu** pacjent walczy z objawami („nie pójde na imprezę bo lęk”), ale rdzeń („jestem wadliwy”) zostaje nietknięty. Ekspozycja zmniejsza lęk sytuacyjny — schemat dalej dyktuje izolację. Schemat to *wzorzec pamięciowo-emocjonalny* uformowany w dzieciństwie, który filtruje doświadczenie dorosłe. *Tryb* to aktywny stan teraz. AvPD oscyluje między *Vulnerable Child* (wewnętrznie) a *Avoidant Protector* (zewnętrznie). Cel ST: dotrzeć do dziecka, wzmocnić *Healthy Adult*, ograniczyć ucieczkę.

01 Cztery główne schematy AvPD (Young 2003)

1 · DEFEKTYWNOŚĆ / WSTYD (CENTRALNY)

„Jestem *fundamentalnie* wadliwy/-a — jeśli mnie **zobaczą**, odrzucą”. Rdzeń AvPD. Wstyd jako baza tożsamości. Każda relacja zagraża ujawnieniem „prawdy”. Maska, ukrywanie, wycofanie.

2 · IZOLACJA SPOŁECZNA

„Nie pasuję nigdzie. Jestem *inny/-a* niż wszyscy”. Poczucie obcości nawet w grupach „swoich”. Brak naturalnej przynależności. Często nakładające się na schemat defektywności.

3 · ZAHAMOWANIE EMOCJONALNE

„Emocje są *niebezpieczne* — pokażą moją słabość/wadliwość”. Tłumienie uczuć, „spokojna twarz”, trudność z płaczem, gniewem, radością. Tryb *Detached Protector* w czystej formie.

4 · PORAŻKA

„Nic mi się nie uda. Inni są lepsi”. Antycypacja klęski przed próbą. Sabotuje podejście do zadań, awansów, relacji. Sukces interpretowany jako szczęście lub pomyłka.

Hierarchia schematów: w AvPD *defektywność* jest niemal zawsze centralna — inne schematy są jej *kompensacjami* lub *rozszerzeniami*. Praca terapeutyczna celuje przede wszystkim w *defektywność*; reszta zwykle zaczyna ustępować równolegle.

02 Trzy tryby Schema Therapy w AvPD



Schema Therapy w AvPD: celem nie jest zniszczenie *Avoidant Protector* (to byłaby utrata jedynej obrony pacjenta) — celem jest *dotarcie do Vulnerable Child za* Protectorem, zaopiekowanie się nim, i powolne zastąpienie ochrony unikającej przez *Healthy Adult*. Punitive Parent (wewnętrzny krytyk) jest *osłabiany*, nie zwalczany.

03 Moje dominujące schematy

DEFEKTYWNOŚĆ/WSTYD (0–10)

— „jestem fundamentalnie wadliwy/-a”

IZOLACJA SPOŁECZNA (0–10)

— „nie pasuję nigdzie”

ZAHAMOWANIE EMOCJONALNE (0–10)

— „emocje są niebezpieczne”

PORAŻKA (0–10)

— „nic mi się nie uda”

04 Dlaczego ST dociera tam, gdzie CBT się odbija

KRÓTKA CBT

Restrukturyzacja myśli, ekspozycja na sytuacje.
Intelektualna zgoda („wiem, że mówisz prawdę”).
Schemat zostaje: „*ale i tak to czuję*”. Lęk sytuacyjny
↓, defektywność = bez zmian.

SCHEMA THERAPY

Przepisywanie obrazów (ang. *imagery rescripting*),
dialog krzesół, limited reparenting. *Doświadczeniowa*
korekta — pacjent **doświadcza**, że Vulnerable Child
może być widoczne i nie odrzucone. Rdzeń ustępuje.

Klucz: Bamelis 2014 (RCT, klaster C zaburzeń osobowości): ST *istotnie* skuteczniejsza niż leczenie standardowe — $d = 0,7-1,0$. W AvPD **schemat defektywności jest niewidoczny** — pacjent ukrywa go tak skutecznie, że nawet doświadczony terapeuta może go nie zauważyć przez miesiące. Sygnały: wycofywanie się z głębszych pytań, ogólnikowość, „nic nie mam do powiedzenia”. Wymaga cierpliwego, *niewstydzącego* pytania. Schema Therapy w AvPD trwa 1-3 lat — krótszy protokół oznacza dotknięcie objawów, ale nie rdzenia.